

TRASTORNOS AFECTIVOS - TRASTORNO BIPOLAR.

Antonio Serrano Garcia

INTRODUCCIÓN

Los trastornos afectivos corresponden a un grupo de patologías en las que su característica principal consiste en una alteración del estado de ánimo. Debe tenerse en cuenta que una alteración anímica resulta relativamente mantenida en el tiempo e independiente de los factores ambientales y no debe confundirse con las emociones que presentan un carácter pasajero y generalmente son reactivas a un hecho determinado.

DIAGNÓSTICO

Entre las alteraciones del estado de ánimo distinguimos principalmente dos tipos:

- Elevación del estado de ánimo (manía): Consiste en cuadro de euforia o disforia mantenida durante al menos una semana y acompañada generalmente de aceleración del pensamiento, disminución de las necesidades de sueño, gastos excesivos, conducta desinhibida y ocasionalmente síntomas psicóticos que suelen consistir en delirios megalomaniacos o mesiánicos.
- Disminución del estado de ánimo (depresión): Consiste en un cuadro de tristeza patológica mantenida durante al menos dos semanas y que desborda lo esperable ante un hecho ambiental determinado. Generalmente se acompaña de apatía, anhedonia, insomnio o hipersomnia, pérdida de peso. Puede aparecer ideación suicida frecuentemente y ocasionalmente síntomas psicóticos que suelen consistir en ideas de ruina, culpa o hipocondría.

Es relativamente frecuente la presencia de estados mixtos en los cuales se identifican síntomas tanto de manía como depresivos.

A la hora de realizar un diagnóstico de un trastorno afectivo en Urgencias es realizar una anamnesis detallada y longitudinal del paciente identificando los diferentes episodios a lo largo de su vida. También es preciso descartar la presencia de cuadros de alteración del estado de ánimo secundarios a enfermedades o sustancias.

Algunas posibles causas de alteración del estado de ánimo secundaria serían:

- Toma de corticoides (manía corticoidea)
- Hipo o hipertiroidismo
- Lesiones cerebrales (principalmente del hemisferio derecho)
- Isquemia o hemorragia cerebral (depresión vascular o post-ictus)
- Consumo de drogas
- Antidepresivos (manía secundaria)
- Antihipertensivos (depresión)
- Encefalitis

TRATAMIENTO EN URGENCIAS

Una vez detectado el cuadro de alteración del estado de ánimo, caracterizado este y descartada la presencia de una alteración anímica secundaria es preciso planificar el tratamiento.

La presencia de un cuadro maniaco requiere generalmente la supervisión continua del paciente hasta que pueda ser valorado por un especialista en Psiquiatría.

En caso de un episodio depresivo es preciso valorar la presencia de ideación autolítica (ver capítulo correspondiente en esta misma obra) y, si no se evidencia su presencia, valorar un abordaje ambulatorio. Puede ser necesario el concurso de un especialista en Psiquiatría.

En caso de alteración afectiva secundaria es probable que deban participar en el tratamiento varios especialistas y, en caso de ser necesaria la hospitalización, se recomienda que esta se realice en un servicio médico con apoyo del Psiquiatra de Enlace del hospital.

El tratamiento farmacológico para un cuadro depresivo generalmente se realiza con antidepresivos y el de un cuadro maniaco se suele realizar con antipsicóticos y/o eutimizantes. En todo caso no se recomienda iniciar el tratamiento de este tipo de cuadros en Urgencias puesto que en ambos casos van a requerir un seguimiento y una planificación a largo plazo que deberá realizar el facultativo que vaya a ser responsable de su evolución longitudinal.

IMPORTANTE

- El tratamiento de un trastorno afectivo debe considerarse a largo plazo. No se recomienda su inicio en el Servicio de Urgencias

BIBLIOGRAFÍA

- 1.- OMS (1992), CIE-10. Décima revisión de la clasificación internacional de las enfermedades. Trastornos mentales y del comportamiento. Descripción clínicas y pautas para el diagnóstico, Madrid. Ed. Méditor.
- 2.- Malhi GS, Outhred T, Hamilton A, Boyce PM, Bryant R, Fitzgerald PB, et al. Royal Australian and New Zealand College of Psychiatrists clinical practice guidelines for mood disorders: major depression summary. Med J Aust. 5 de marzo de 2018;208(4):175-80.